A morte da empatia e a vitória da indiferença

Pensadores brasileiros analisam as razões da ausência de comoção nacional pelo fato de o Brasil atingir a marca de cem mil óbitos pela COVID-19

BERTHA MAAKAROUN

O Brasil fracassou no enfrentamento à pandemia da COVID-19. Além de não ter conseguido evitar a fúnebre coleção de corpos empilhados sob as estatísticas do novo coronavírus, que já alcançaram os seis dígitos, este mais recente recorde de mortes é recebido com indiferença por parcelas significativas da sociedade brasileira: seja pelo negacionismo da doença e da ciência ou por declarações de autoridades, que reforçam certo desdém face à perda de "alguns tipos" de vida: "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?". Se as vítimas de morte já são mais de 100 mil em agosto, o modelo estatístico do Instituto for Health Metrics and Evaluation da Universidade de Washington (Seattle) aponta para a dramática estimativa de 192,5 mil mortos até 1º de dezembro, segundo assinala o epidemiologista Rômulo Paes, pesquisador titular da Fiocruz Minas e consultor sênior da ONU em proteção social junto ao Birô de Crise e ao Centro Regional para a África.

Assim, o calvário da pandemia alcançará as celebrações natalinas com as mortes naturalizadas. Sem empatia com o luto do outro, boa parte da sociedade continuará fazendo jus à tradição cultural racista, hierárquica e patrimonial, já que as maiores vítimas de morte da COVID-19 – pobres e pardos – partilham de igual perfil das vítimas "invisíveis", que mais morrem da violência policial na lida da sobrevivência nas periferias. "Nada se distribui igualitariamente no Brasil. Os efeitos letais da pandemia se concentram nas classes subalternas, nos territórios vulneráveis, portanto, são efeitos experimentados desigualmente. E o Brasil continua passando ao largo disso", considera Luiz Eduardo Soares, cientista político, antropólogo e escritor.

Será a morte da empatia? "A sociedade de uma forma geral não se comove, não se revolta, não se transporta para o lugar dessas famílias enlutadas: não age contra o massacre, o banho de sangue, o genocídio das vítimas da violência e, de igual maneira, a situação também se repete nesta pandemia", considera Luiz Eduardo Soares. "Chegamos à marca de 100 mil mortos, e o governo vira o rosto, negligencia. Isso se tornou um espetáculo cotidiano, ao qual a sociedade parece ter se acostumado", avalia. Ressalvando a ação de grupos específicos que atuam em defesa solidária e altruísta aos mais vulneráveis de forma episódica e circunstancial, Luiz Eduardo Soares considera a falta de empatia uma característica dominante da sociedade brasileira.

"Se vivêssemos uma cultura igualitária, sentiríamos repulsa pela ordem social vigente, não só hoje, mas historicamente, marcada pelo racismo estrutural e desigualdades tão profundas. Já a teríamos transformado", afirma. Além disso, tais valores igualitários não são trabalhados da forma como deveriam no processo educacional no país, pelo qual determinados elementos da cultura são transmitidos e incorporados, considera Luiz Eduardo Soares. "Por isso, segmentos muito numerosos se mostram absolutamente frios, indiferentes e até refratários à compaixão e à empatia. A empatia é vivida a conta-gotas, homeopaticamente, e se distribui apenas entre os iguais", frisa ele.

Considerando a empatia uma meta – ou utopia – a ser alcançada, o escritor Ailton Krenak, doutor honoris causa pela Universidade de Juiz de Fora e um dos mais destacados ativistas do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas, faz coro com Luiz Eduardo Soares ao sustentar a importância da educação e da cultura para a vivência da empatia e de sociedades mais justas. Mas parte de uma perspectiva da natureza humana diferente da noção de Jean Jacques Rosseau: "É preciso parar com a ilusão de achar que é natural e espontâneo no ser humano a solidariedade, o afeto", afirma. Em contraposição à dimensão humana do labor – atividade corporal natural e indispensável à sobrevivência –, Ailton Krenak faz analogia da empatia a um tecido em construção. "Imagine o sofrimento íntimo ao ouvir daquele que é responsável pela governança, por inspirar uma ideia de governo no país, dizer: 'Já deu 100 mil, aí? Então toca pra frente, vai tocando'". Para o escritor, esse comportamento do presidente Jair Bolsonaro semeia um ambiente social de irritação e de ódio. "Infelizmente, não temos líderes, mas, antes, estão em cargos de comando gerentes sem empatia alguma, que administram linhas de produção, linhas de morte, administram coisas", afirma Ailton Krenak.

A cooperação para a ação coletiva é fundamental para o enfrentamento da pandemia. Nesse contexto, o individualismo exacerbado e o conformismo face às injustiças, de base cultural, mas também de grande influência fundamentalista neopentecostal, são alguns dos aspectos que explicam a falta de empatia de grande parte da sociedade brasileira face às mortes, avalia o cientista social Robson Sávio, coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. "Assistimos à descrença na possibilidade da ação do estado, de ações coletivas, em prol do bem comum, porque há difuso um sentimento de criminalização da política, do bem público, de criminalização das noções de coletividade, de fraternidade, de associativismo", afirma ele, lembrando que, na guerra ideológica do governo, as ações solidárias são associadas à ideia de "comunismo" e postas em termos de "encarnação do mal" a ser combatido.

UM PAÍS DIVIDIDO

Sem qualquer interesse em agir para unificar o país e a ação de enfrentamento à pandemia, o governo federal dobrou a sua aposta no confronto à ciência e às orientações de organismos internacionais. A estratégia focada em desautorizar as autoridades simbólicas – como universidades, a imprensa, a justiça, os intelectuais – procura destituir os poderes impessoais nelas representados para o deslocamento da autoridade àquele que as desafia, ou seja, o presidente da República, analisa o psicanalista Christian Dunker.

"A pandemia chegou ao Brasil e encontrou uma gestão que aposta na polarização e na divisão do país como método de governo. Tínhamos já, em nosso momento, uma séria divisão, a partir da ascensão de um discurso que foi eleito na base da produção de inimigos, para justificar ações intempestivas, ações que acumulam poder naquele que está governando o país e naqueles que o cercam", observa Dunker. "E o que acontece quando esse método enfrenta uma pandemia, que não é inimigo político, é um fato que vem da natureza, vem desse lugar terceiro, que não se pode admitir como algo que nos une?", indaga. Como esse "terceiro" teria potencial para unificar o país, a negação da doença e da ciência, que aponta para as formas de combate, tornaram-se fundamentais para a manutenção da narrativa da guerra.

E tal narrativa foi mantida, mesmo diante da perspectiva de mais perdas de vidas. "O negacionismo representou um prejuízo dramático para o enfrentamento da COVID, porque nessa hora, para obedecer, para que todos fizessem o sacrifício, temos de recorrer às figuras de autoridade. E nessa hora encontramos uma divisão na política sanitária, marcada por uma hesitação e está marcada pela negação do consenso científico", considera Dunker. "Isso custou a vida de milhares de brasileiros", diz ele.

Opinião semelhante manifesta o epidemiologista Rômulo Paes. "O Brasil fracassou no combate à pandemia", sintetiza. "A adesão aos comportamentos de prevenção em relação às doenças depende da forma como as pessoas percebem a pandemia e da forma como se veem nesse contexto", aponta ele. Se não compreendem a vantagem do isolamento social; se não veem o quanto esse comportamento contribui para a saúde de todos – e nesse sentido é uma atitude empática altruísta e solidária –, não vão aderir às medidas indicadas, acrescenta ele, lembrando que o debate político em torno da pandemia apontou para uma deslegitimação da ciência em alguns momentos e para a falsificação em relação a determinadas terapêuticas. "Essa mensagem conflituosa, desorganizada, atrapalhou muito o entendimento da população sobre quais são os verdadeiros riscos e o que a sociedade como um todo ganharia se fôssemos mais diligentes e solidários nas atitudes de prevenção", conclui.

"Nada se distribui igualitariamente no Brasil. Os efeitos letais da pandemia se concentram nas classes subalternas, nos territórios vulneráveis, portanto, são experimentados desigualmente. A empatia é vivida a conta-gotas, homeopaticamente, e se distribui apenas entre os iguais."

● Luiz Eduardo Soares, cientista político, antropólogo e escritor

"Infelizmente, não temos líderes, mas, antes, estão em cargos de comando gerentes sem empatia alguma, que administram linhas de produção, linhas de morte, administram coisas."

● Ailton Krenak, escritor e ativista

"Assistimos à descrença na possibilidade da ação do Estado, de ações coletivas em prol do bem comum, porque há difuso um sentimento de criminalização da política, do bem público, de criminalização das noções de coletividade, de fraternidade, de associativismo."

● Robson Sávio, cientista social

O IMPACTO DA AUSÊNCIA DO RITO FUNERÁRIO

FELIPE RICCIO
ESPECIAL PARA O EM

A imagem de um homem palestino que escalou a parede de um hospital para ver a mãe, internada com o novo coronavírus, repercutiu no mundo todo. Sentado na janela e com os olhos fixos na mãe, a angústia daquele rapaz está, hoje, cravada no peito de muitas pessoas ao redor do mundo.

Com uma alta taxa de transmissibilidade, uma vez infectada, a pessoa deve se isolar. Quando os sintomas dão seus sinais mais fortes e a internação se faz necessária, o reencontro dependerá da recuperação do paciente. Caso a doença o leve à morte, ninguém mais poderá vê-lo. Daí o desespero do homem palestino que não hesitou em escalar, durante dias, as paredes do hospital. Ele descia somente quando sua mãe tinha pegado no sono. Infelizmente, Rasmi Suwati, de 73 anos, não resistiu.

Provavelmente, as imagens da mãe pela janela serão as últimas que Jihad Al-Suwati terá em sua recordação. Por causa da doença, os ritos funerários ficam também inviabilizados. É certo que esses ritos variam entre as diferentes culturas, mas é difícil pensar alguma sociedade em que a morte não tenha um aspecto central. Dado o caráter pandêmico do coronavírus, a ausência dos ritos funerários é mais um dos ingredientes nocivos à psique. Os traumas que a ausência de um lugar individualizado de memória pode causar, juntamente com a ausência dos demais ritos – como a solidariedade de parentes e amigos, a missa de corpo presente, os cânticos – ainda estão longe de poder ser mensurados, mesmo que seus efeitos já estejam presentes depois de meses de pandemia.

Isso se agrava ainda mais se levarmos em conta que nos dois países que mais mortes tiveram até agora por causa do coronavírus, Estados Unidos e Brasil, os ritos em torno da morte são expressivos. Aqui e lá, a morte é também uma hora de grande investimento, como fica explícito na quantidade de planos funerários existentes nos dois países. Ademais, é uma cerimônia coletiva repleta de símbolos. Nos Estados Unidos, para termos uma ideia, há cursos de bacharelado em ciências mortuárias. Ainda assim, parece pouco provável que os governos dos dois países colocarão em pauta políticas de assistência psicológica para as famílias que perderam pessoas pela COVID-19.

RITOS FUNERÁRIOS

No nosso país, a relação entre ritos funerários e epidemias vem de longa data. Exploraremos o período que vai da revolta popular que ficou conhecida como "cemiterada", na cidade de Salvador, nos idos de 1836, até a epidemia de cólera ocorrida em 1855 e 1856. A "cemiterada" é um indicativo forte de como modificações abruptas em torno dos ritos funerários podem até mesmo descambar em cenas de violência. No Brasil oitocentista, a morte tinha características barrocas acentuadas: muitos símbolos, protocolos sagrados, vestimentas e cortejos fúnebres – que já eram estipulados nos testamentos. Diferentemente de hoje, entretanto, durante a primeira metade do século os enterros se davam no interior das igrejas. A seleção do local em que cada pessoa era enterrada não era algo meramente ocasional. Havia uma geografia complexa que deixava entrever as desigualdades envoltas no momento da morte. Sendo assim, as pessoas podiam ser enterradas no altar-mor, na entrada do templo, debaixo da pia.

Esse contato estreito entre mortos e vivos foi favorecido, desde a Idade Média, pela criação de uma nova região celestial: o purgatório. Aos vivos estava aberta a possibilidade de proporcionar uma saída mais rápida desse local. Colocava-se em prática uma "economia da salvação", em que as irmandades tinham papel central. As pessoas ingressavam nas irmandades em busca, entre outras coisas, de um enterro digno. Aos seus membros cabia acompanhar os mortos até a sua sepultura. Pessoas mais abastadas não raro participavam de mais de uma irmandade.

Ainda que fosse a regra no Brasil oitocentista, essas práticas eram condenadas pela Igreja desde o século 16, com o Concílio de Trento, quando foram demarcadas fronteiras entre o culto do divino e o culto dos mortos – este típico das religiosidades pagãs. Condenada pelo alto clero, era fonte de renda importante para os representantes do baixo clero, que arrecadavam as taxas embutidas no processo.

No entanto, um ano após a Revolta dos Malês – que colocara fim a um período de grandes revoltas escravas que abalaram os primeiros decênios do século – a edição de uma lei provincial estipulou que, daí em diante, os enterros nas igrejas estavam proibidos. Para seu lugar tinha sido construído um cemitério cuja administração ficaria a cargo de uma empresa privada pelo período de trinta anos. A reação não tardou.

Três dias após a inauguração do cemitério, o local foi tomado por populares. Enfurecidos, colocaram os muros abaixo, quebraram as sepulturas e não pouparam sequer as capelas. O ato teve efeito e a lei foi revogada. Os enterros nas igrejas perdurariam por mais 19 anos. Assim, somente no auge da epidemia da cólera, nos idos de 1855, o cemitério foi reaberto. O motivo tinha a ver com a epidemia que ceifou cerca de 300 mil vidas no Brasil. Somente em Salvador, conforme João José Reis, chegou a vitimar em torno de 10% da população. Não caberiam tantos mortos no interior das igrejas. E, ademais, os vivos tinham grande receio de que pudessem ser acometidos pela doença no contato com os mortos.

Mas as semelhanças não pararam por aí. Assim como a COVID-19, a epidemia da cólera, pelo número elevado de mortes, provocou inúmeros traumas na população coeva. O enterro não apenas se modificou de lugar, mas, em muitos casos, tornou-se impossível. Em muitas cidades e vilas do Brasil oitocentista, pessoas mortas eram abandonadas pelas ruas, e até mesmo queimadas, em cenas similares às ocorridas recentemente no Equador em decorrência do coronavírus.

Cabe destacar que tanto a cólera como a COVID-19 tiveram como principais vítimas pessoas mais pobres, sobretudo negras. Para o caso da cólera na cidade do Rio de Janeiro, no biênio 1855-56, se os negros foram os mais atingidos, a letalidade para os africanos foi ainda maior do que a dos crioulos – isto é, negros e negras nascidos no Brasil –, pois estes estavam mais inseridos em redes de solidariedade que ajudavam os doentes. Para o caso do coronavírus, muitas lideranças dos movimentos negros têm alertado para uma coleta indevida dos dados, afetando a mensuração de mortes por raça. Mesmo com eventuais subnotificações, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, por exemplo, a letalidade da doença é 46% maior entre pessoas declaradas pretas em relação às brancas no estado. Com acessos tão discrepantes à hospitalização e aos cuidados de saúde, a morte torna-se altamente desigual.

Como nos ensinou Émile Durkheim, a união das pessoas está diretamente ligada aos ritos e às cerimônias. Em momentos de transição – e a morte é um deles – a solidariedade do grupo é reafirmada por meio dos ritos coletivos nos quais os participantes se veem na obrigação de se adaptar a uma modificação no curso de suas vidas. Dessa maneira, no contexto em que vivemos, à dor imensurável da perda somam-se os abalos nas personalidades dos que ficam.

*

Felipe Riccio é doutor em ciência política, professor e historiador